

Ojo rojo doloroso

1. Introducción y relevancia clínica

El **ojo rojo doloroso** representa una de las **consultas oftalmológicas más comunes** tanto en atención primaria como en urgencias.

Se caracteriza por la **hiperemia conjuntival** acompañada de **dolor ocular**, que puede ir desde una leve molestia hasta dolor severo, asociado o no a disminución de la agudeza visual.

Relevancia clínica

- El **ojo rojo doloroso** puede deberse a **procesos benignos y autolimitados** (como conjuntivitis o cuerpo extraño), pero también a **enfermedades graves y potencialmente cegadoras**, como el **glaucoma agudo**, la **uveítis anterior**, la **queratitis infecciosa** o la **escleritis**.
 - Su **evaluación rápida y sistemática** permite distinguir los casos que requieren **derivación urgente al oftalmólogo** de aquellos que pueden manejarse en atención primaria.
 - En el **EUNACOM**, este tema se pregunta frecuentemente para evaluar la **capacidad del médico general de reconocer signos de alarma** y diferenciar patologías superficiales de las profundas.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Concepto de ojo rojo

El color rojo ocular resulta de la **vasodilatación de los vasos de la conjuntiva y/o episclera**, provocada por inflamación, irritación o congestión venosa.

Según la **estructura comprometida**, el patrón de hiperemia cambia:

**Tipo de
hiperemia**

Estructura afectada

Características

Conjuntival	Conjuntiva bulbar y palpebral	Vasos móviles, inyección difusa, blanquean con vasoconstrictor.
Ciliar (periquerática)	Córnea, iris o cuerpo ciliar	Vasos profundos, fijos al limbo, no blanquean; color violáceo.
Mixta	Ambas	Indica compromiso corneal o intraocular.

2.2 Mecanismos fisiopatológicos del dolor

El dolor ocular proviene de:

- Terminaciones del nervio trigémino (V par).
 - Irritación corneal o epiescleral.
 - Inflamación del cuerpo ciliar (uveítis).
 - Aumento agudo de presión intraocular (glaucoma agudo).
 - Necrosis escleral o perforación.
-

2.3 Clasificación general de causas de ojo rojo doloroso

Grupo	Ejemplos	Gravedad
Triviales / autolimitados	Conjuntivitis, cuerpo extraño, blefaritis	Leve
Moderados	Queratitis superficial, abrasión corneal	Requieren control

Graves / urgentes	Uveítis, glaucoma agudo, queratitis infecciosa, escleritis, endoftalmitis	Derivación inmediata
--------------------------	---	----------------------

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Signos y síntomas orientadores

Síntoma / signo	Orienta a
Dolor leve + secreción mucosa	Conjuntivitis bacteriana
Dolor intenso + fotofobia + visión borrosa	Queratitis o uveítis
Dolor + halos + náuseas + pupila media fija	Glaucoma agudo
Dolor punzante + cuerpo extraño	Erosión corneal
Dolor profundo + color violáceo escleral	Escleritis
Dolor severo + hipopión + cirugía ocular previa	Endoftalmitis

3.2 Diagnóstico diferencial principal del ojo rojo doloroso

Etiología	Clínica principal	Hallazgos clave	Dolor	Visión
Conjuntivitis	Secreción, sensación arenosa	Inyección conjuntival difusa	Leve	Normal

Cuerpo extraño / erosión corneal	Antecedente traumático	Lesión con fluoresceína (+)	Moderado	Normal
Queratitis bacteriana / herpética	Dolor + fotofobia	Opacidad corneal, úlcera	Intenso	Disminuida
Uveítis anterior	Dolor profundo + fotofobia	Miosis, flare y células	Moderado	Disminuida
Glaucoma agudo	Dolor intenso, halos, náuseas	Córnea opaca, pupila media fija	Muy intenso	Muy disminuida
Escleritis	Dolor que despierta al paciente	Hiperemia azulada	Intenso	Variable
Endoftalmitis	Postcirugía/trauma, hipopión	Cámara anterior turbia	Muy intenso	Muy disminuida

3.3 Signos de alarma en ojo rojo doloroso

Todo paciente con alguno de los siguientes signos requiere **evaluación oftalmológica urgente**:

- Pérdida visual.
- Dolor intenso o profundo.
- Fotofobia marcada.
- Pupila anómala (miosis o fija).
- Córnea opaca o con úlcera visible.
- Hipopión o hipema.

- Antecedente de cirugía ocular reciente o trauma.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En atención primaria

1. **Agudeza visual monocular.**
Disminución → derivar urgente.
2. **Inspección con luz focal:** detectar secreción, cuerpo extraño, edema o úlcera.
3. **Tinción con fluoresceína:** identifica lesiones epiteliales corneales.
4. **Reflejo pupilar:**
 - Miosis dolorosa → uveítis.
 - Pupila media fija → glaucoma agudo.
5. **Medición de presión intraocular (si disponible).**
6. **Eversión palpebral** (descartar cuerpo extraño).

4.2 En atención especializada

Examen	Utilidad
Biomicroscopía (lámpara de hendidura)	Evalúa cámara anterior y córnea.
Tonometría	Confirma glaucoma agudo.
Cultivo corneal o de secreción	En úlceras o queratitis sospechosas.

Fondo de ojo

Evalúa compromiso de nervio óptico o retina.

Ecografía ocular (modo B)

Si opacidad de medios.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF)

El tratamiento depende de la **etiología sospechada**. El objetivo inicial en APS es **aliviar el dolor, prevenir infección y derivar los casos graves**.

5.1 Conducta terapéutica general

- **Analgesia sistémica (AINE o paracetamol).**
 - **Lubricantes oculares (lágrimas artificiales)** si irritación leve.
 - **Evitar corticoides tópicos sin diagnóstico.**
 - **Suspender lentes de contacto.**
 - **Derivación inmediata** si pérdida visual o sospecha de patología grave.
-

5.2 Tratamiento según diagnóstico principal

A. Conjuntivitis bacteriana

- Limpieza con suero fisiológico.
- **Antibiótico tópico (ciprofloxacino 0,3% o tobramicina 0,3%)** cada 4–6 h.
- Educación: no frotar ojos, lavado de manos, no compartir toallas.

B. Cuerpo extraño / erosión corneal

- Retirar cuerpo extraño visible.

- **Antibiótico profiláctico** (eritromicina o gentamicina ungüento).
- No usar lentes de contacto ni parches oculares.
- Control en 24 h si síntomas persisten.

C. Queratitis bacteriana

- **Fluoroquinolona tópica (moxifloxacino 0,5%)** cada hora.
- Derivación urgente.
- No usar corticoides tópicos.

D. Queratitis herpética

- **Aciclovir ungüento oftálmico** 5 veces/día por 7 días.
- Contraindicado el uso de corticoides tópicos.

E. Uveítis anterior

- **Midriático/ciclopléjico (atropina o ciclopentolato)** para aliviar espasmo ciliar.
- **Corticoide tópico (prednisolona 1%)** bajo indicación oftalmológica.
- Buscar causas sistémicas (artritis, tuberculosis, VIH).

F. Glaucoma agudo de ángulo cerrado

- **Acetazolamida 500 mg EV o VO.**
- **Manitol 20% 1 g/kg EV.**
- **Timolol y brimonidina tópicos.**
- **Pilocarpina 2%** una vez reducida la PIO.
- Derivación urgente para **iridotomía láser.**

G. Escleritis

- **AINES sistémicos (ibuprofeno 600 mg cada 8 h).**

- En casos severos: **corticoides sistémicos (prednisona 1 mg/kg)**.
- Derivación para estudio reumatológico.

H. Endoftalmitis

- **Emergencia ocular absoluta.**
- Ingreso hospitalario y **antibióticos intravítreos** (vancomicina + ceftazidima).
- Posible **vitrectomía quirúrgica**.

6. Complicaciones y pronóstico

Patología	Complicación	Pronóstico
Conjuntivitis	Queratitis secundaria	Bueno
Erosión corneal	Úlcera corneal	Bueno si tratada
Queratitis bacteriana	Perforación corneal	Variable
Uveítis	Sinequias, catarata	Bueno si tratada precozmente
Glaucoma agudo	Atrofia del nervio óptico	Grave
Escleritis	Necrosis escleral	Variable
Endoftalmitis	Pérdida total del ojo	Grave

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. Ojo rojo + dolor + disminución visual = derivar urgente.
 2. Glaucoma agudo → dolor, halos, náuseas, pupila media fija.
 3. Queratitis herpética → úlcera dendrítica fluorescente; no usar corticoides.
 4. Uveítis → miosis dolorosa, fotofobia, flare en cámara anterior.
 5. Escleritis → dolor profundo, color violáceo, no blanquea con vasoconstrictor.
 6. Endoftalmitis → cirugía o trauma previo + hipopión = emergencia.
 7. Siempre medir **agudeza visual** antes de iniciar tratamiento.
-

Errores comunes

- Usar colirios con corticoides sin diagnóstico claro.
 - No valorar visión ni reflejo pupilar.
 - No derivar a oftalmología cuando hay dolor intenso o visión borrosa.
 - Aplicar parche ocular en úlceras o infecciones.
 - Diagnosticar erróneamente glaucoma como “conjuntivitis grave”.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **ojo rojo doloroso** requiere descartar causas graves: **glaucoma agudo, uveítis, queratitis o escleritis**.
2. **Dolor + disminución visual = derivación urgente.**
3. **Glaucoma agudo** → dolor, halos, pupila fija y náuseas → acetazolamida + manitol + oftalmólogo.

4. **Queratitis herpética** → **úlceras dendríticas** → **aciclovir tópico; sin corticoides.**
5. **Uveítis** → **miosis dolorosa** → **midriáticos + corticoides tópicos bajo control.**
6. **Endoftalmitis** es una **emergencia vital ocular** tras cirugía o trauma.
7. Siempre **medir agudeza visual, reflejo pupilar y evaluar córnea.**